

結論：MR 君の「配信対象」と「配信内容」を変え、
費用 +8.4 万円で売上 +893 万円を狙う（全国・年・試算）

結論

何をするか	全国の効果（年・試算）	次の一手
提案① 配信対象 高ポテンシャル医師に年 12 回 潜在 0 ～ 2 人の医師は隔月（年 6 回）	A 案（提案① + ②） 売上 +893 万円 / 費用 +8.4 万円	まず A 案で検証 既読率・理解度・処方率を 配信の群ごとに比べる
提案② 配信内容 診療科ごとに重視テーマから届ける （内科は飲み合わせ、耳鼻は 24h 持続性）	B 案（A 案 + 潜在 5 ～ 7 人） 売上 +2,355 万円 / 費用 +297.3 万円	効果を確認後 B 案 → 全国展開を判断

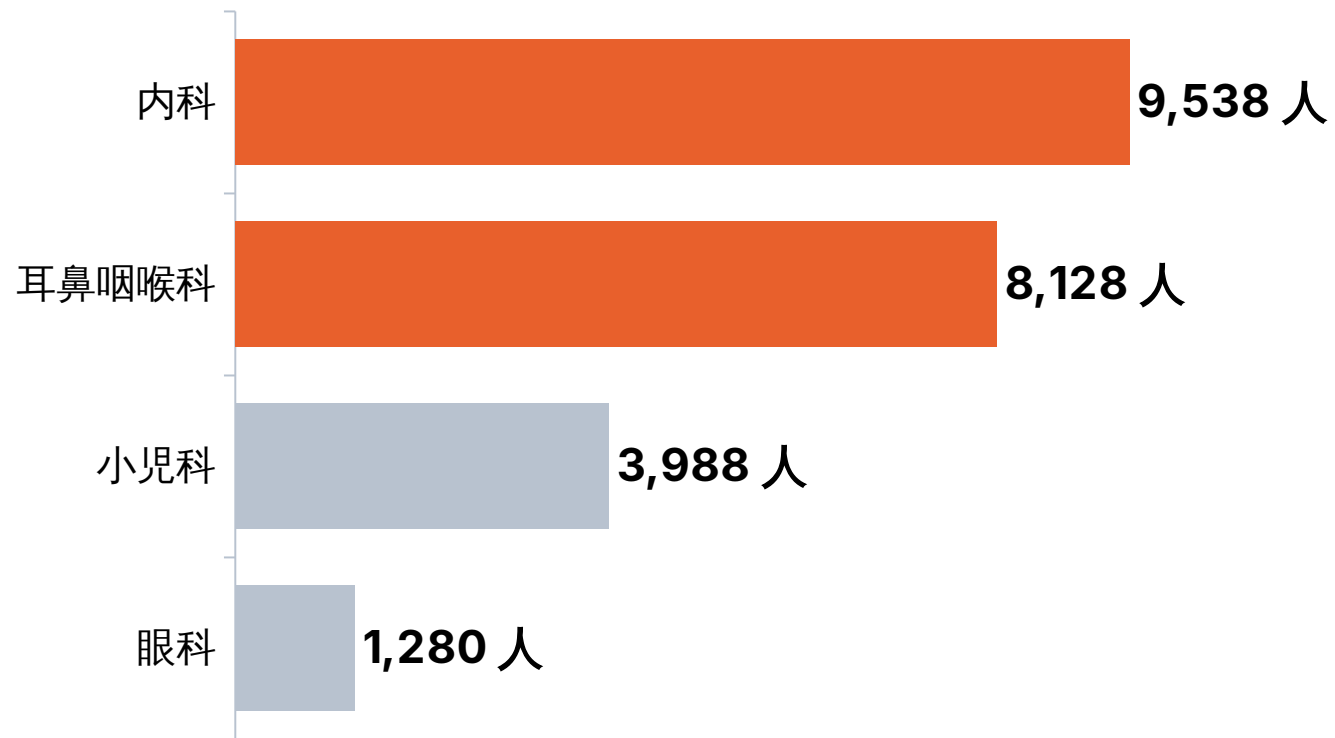
5,000 名の回答データから配信ルールを設計し、同じルールを全国の対象医師へ展開する

根拠：誰に (p.2 ～ 3) → 何を (p.4) → 何回 (p.5 ～ 6) → 費用 (p.7 ～ 8) → 全国の売上 (p.9)

潜在未処方患者の 77% は内科・耳鼻咽喉科に集中。 その 41% を潜在 8 人以上の医師が持つ

現状

診療科別の潜在未処方患者（人）



41%

内科・耳鼻の医師の 21%(701 名)
が、潜在の 41% を持つ

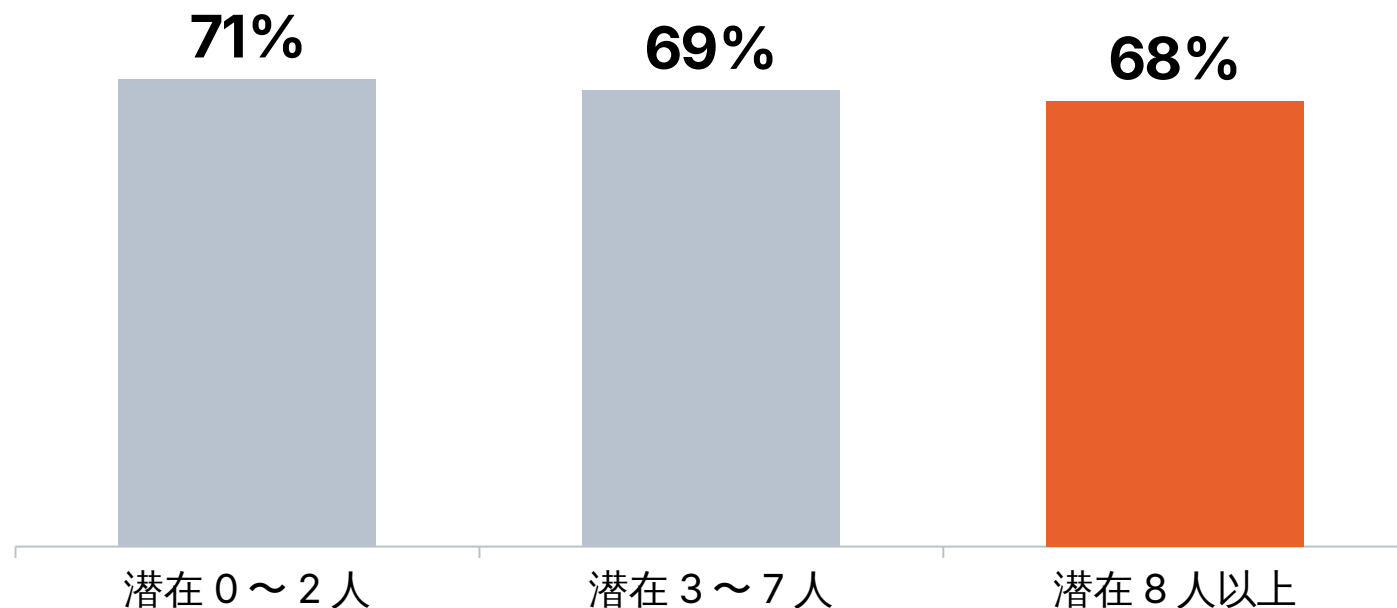
潜在 8 人以上の医師 = 高ポテンシャル医師

→ 内科・耳鼻で潜在 8 人以上の 701 名を「高ポテンシャル医師」とする

配信率は潜在患者数と無関係に約 7 割。 高ポテンシャル医師 191 名には MR ・ MR 君が届いていない

現状

MR 君の配信率（潜在未処方的人数別）



191 名

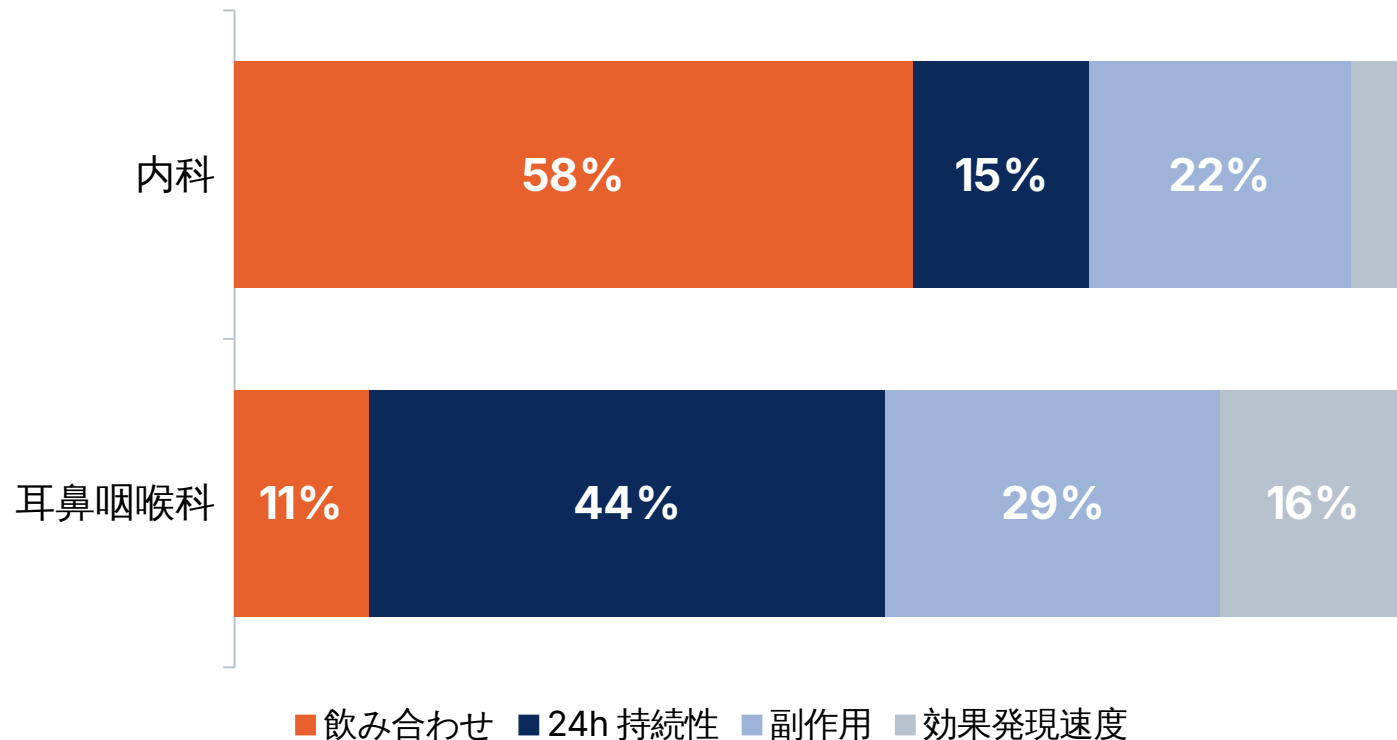
高ポテンシャル医師 701 名のうち、
MR も MR 君も届いていない医師
1 人あたり潜在未処方 10.7 人

→ 問題①「届け先」：配信対象を潜在患者数で選び直す

重視する情報は診療科で違う。 内科は飲み合わせ、耳鼻科は 24h 持続性・副作用

現状

高ポテンシャル医師が最も重視する特性



17% vs 51%

MR 面談を受けている医師の割合

高ポテンシャル医師 17%

処方が多い類似医師 51%

(同じ診療科・患者数・施設区分)

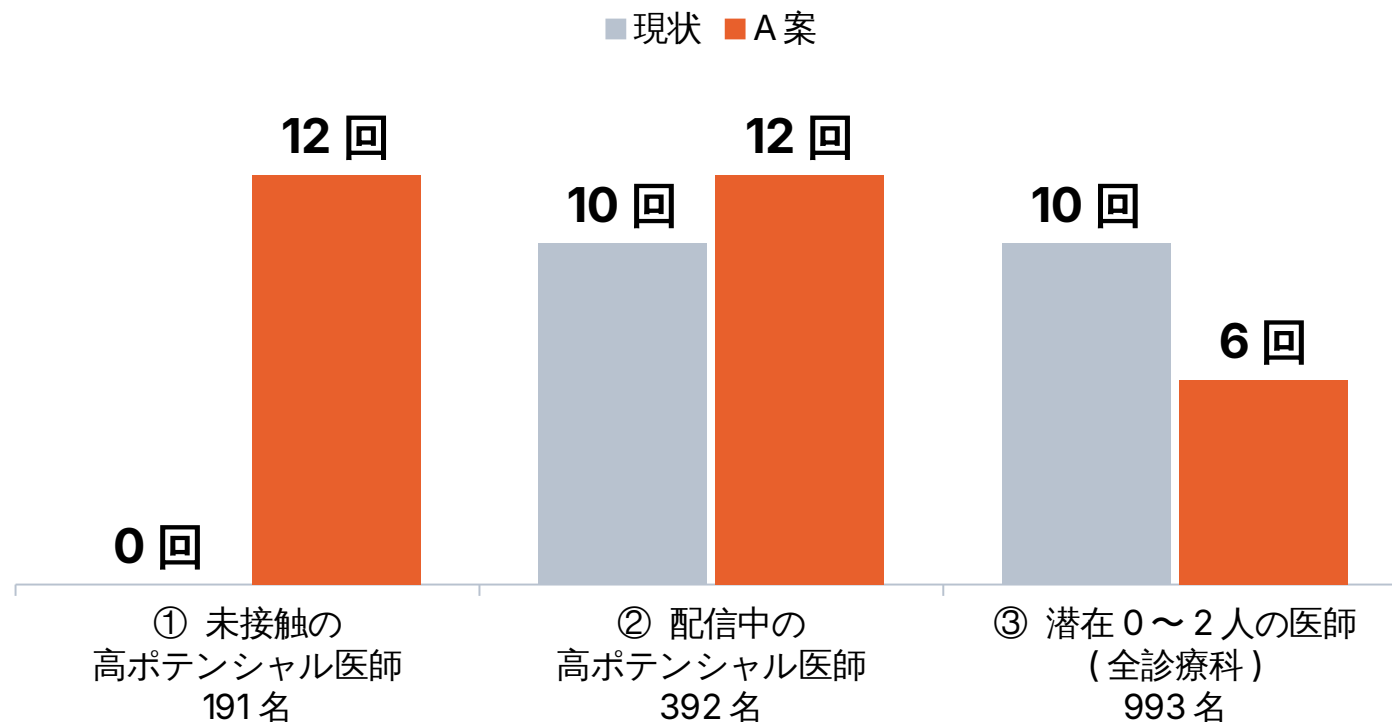
差は関連であり、因果ではない

→ 問題②「内容」：診療科ごとに重視される情報から届ける。MR との接点は MR 君で補う

提案① 配信対象：高ポテンシャル医師は年 12 回、潜在 0 ～ 2 人の医師は隔月（年 6 回）に

提案①

誰に・何回（医師 1 人あたりの年間配信回数）



年 12 回

高ポテンシャル医師への提案頻度

既存 10 本 + 未読上位の再配信 2 回

最適な回数は未検証 (A 案で検証)

MR との連携

MR 面談あり医師は処方率 +4.1pt (関連)

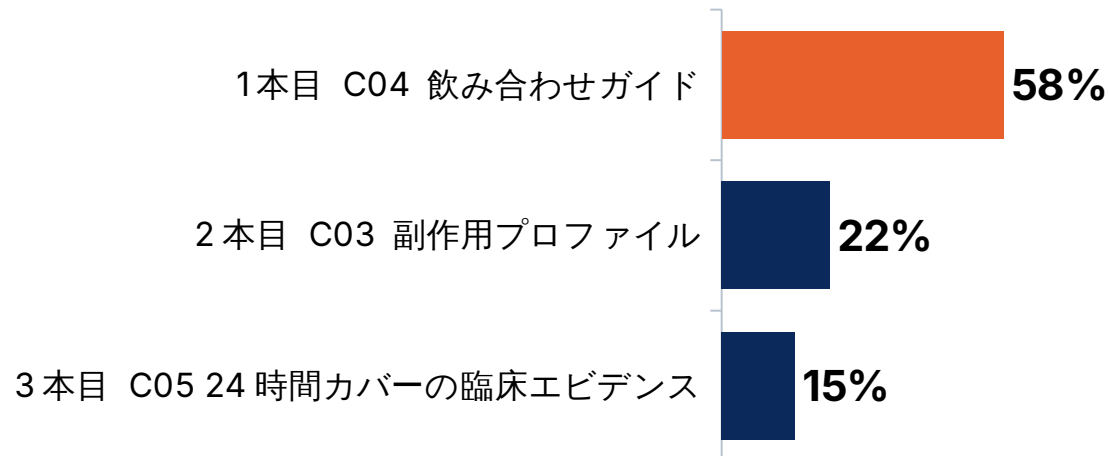
→ 同じリストを MR 訪問の優先先に共有

→ 配信を潜在の多い医師に寄せ、少ない医師はゼロにせず隔月にする

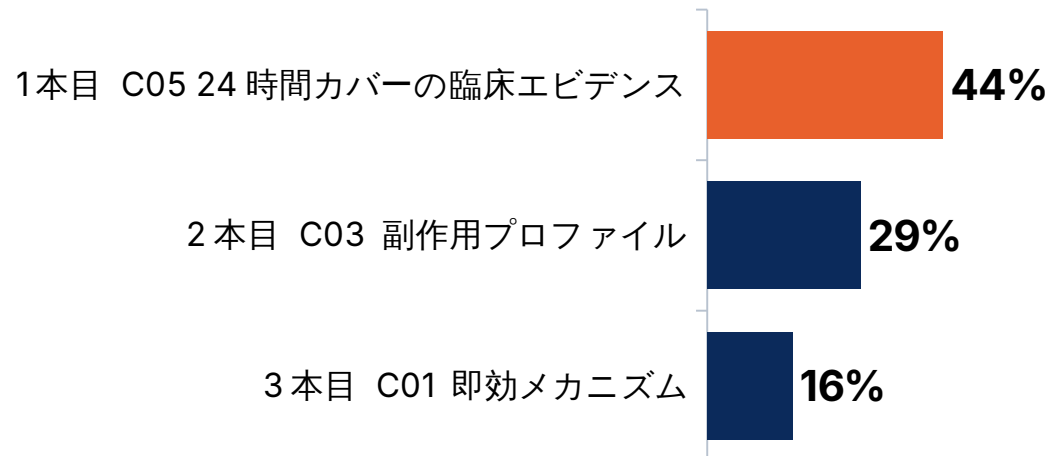
提案② 配信内容：診療科別に届ける順番を変える。 内科は飲み合わせ、耳鼻科は 24h 持続性から

提案②

内科の高ポテンシャル医師に届ける順番



耳鼻咽喉科の高ポテンシャル医師に届ける順番



約 9 割

計画上、3 本目までに高ポテンシャル医師の約 9 割の最重視テーマが含まれる

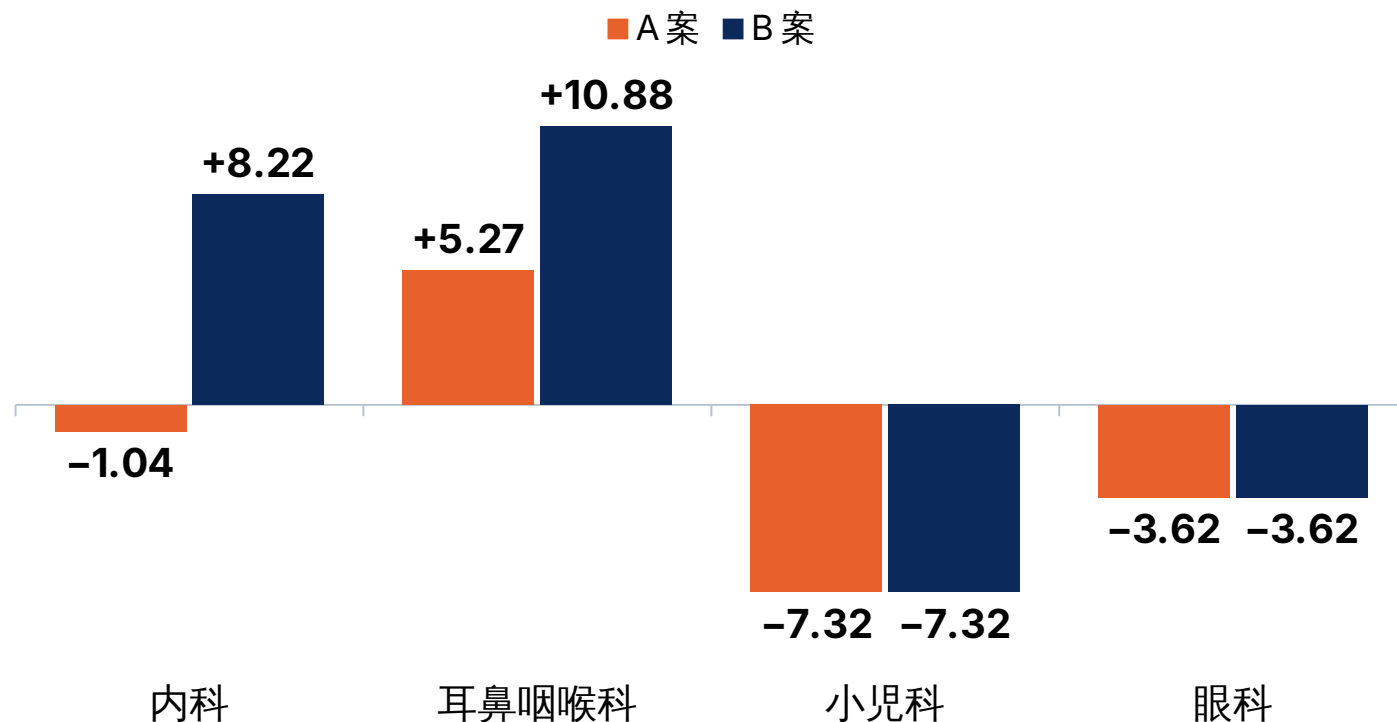
内科 95%・耳鼻咽喉科 89%(計画上のカバー率。実際の既読率ではない)。実測：重視テーマの既読率 13.9% vs その他 11.0%(約 1.3 倍、関連)

→ 既存の 10 本の順番を変えるだけ(新規制作なし)

回答医師 5,000 名では、A 案は費用が 6.71 万円減り、 B 案は A 案より 14.87 万円増える

費用 (5,000 名)

診療科別の費用の変化 (現状比、年、万円)



費用 (既読課金、年)

現状
160.16 万円

A 案 = 提案① + ②
153.45 万円 (-6.71 万円)

B 案 = A 案 + 未接触・潜在 5～7 人の 260 名
168.32 万円 (A 案比 +14.87 万円)

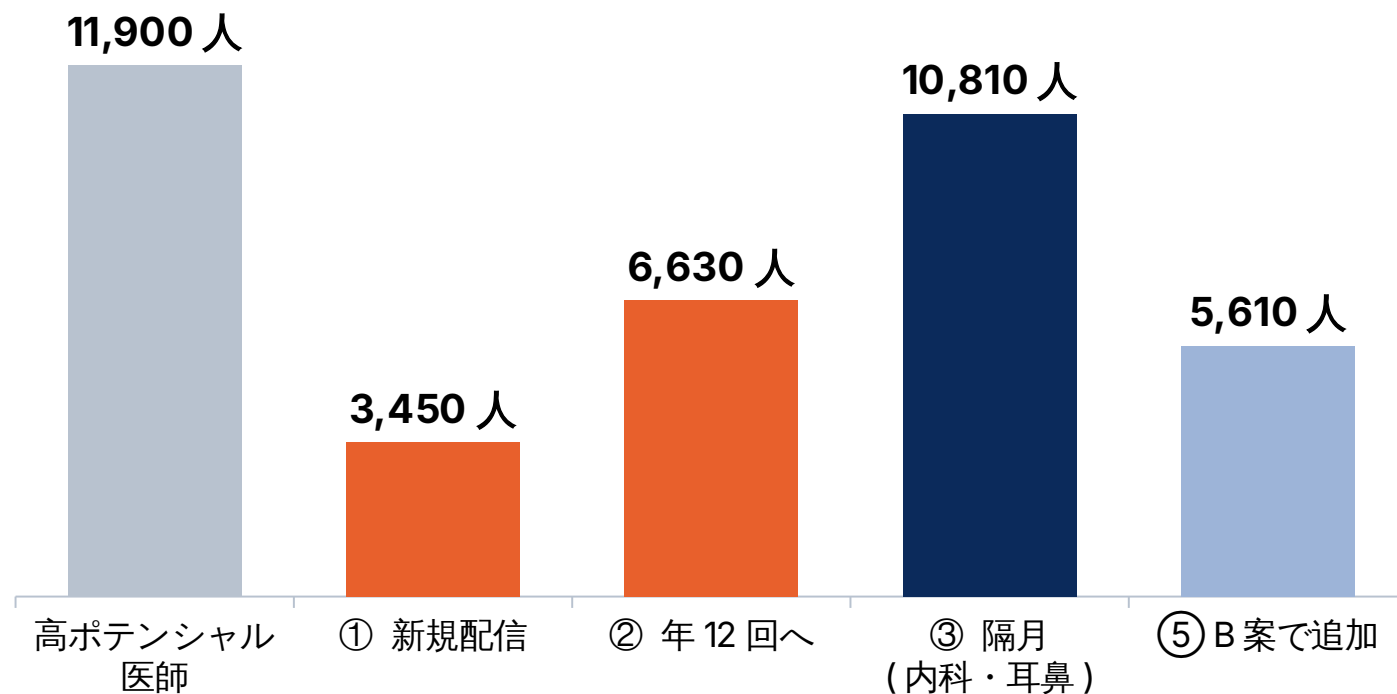
A 案の内訳
内科・耳鼻 +4.23 万円
小児・眼科 -10.94 万円

A 案の節約は主に小児科・眼科の隔月化 → 内科・耳鼻だけを広げる全国では費用は少し増える

全国の内科・耳鼻へ科別に広げると、高ポテンシャル医師は約 11,900 人。費用の増加は A 案 +8.4 万円 (推計)

全国展開

全国の対象医師数 (内科・耳鼻、推計)



計算の流れ (科別)

倍率 = 全国医師数 ÷ 回答医師数

内科 $62,161 \div 2,072 = 30.0$ 倍

耳鼻 $9,330 \div 1,214 = 7.69$ 倍

費用の変化 = 5,000 名での変化 × 倍率 × 90%

A 案 +8.4 万円

(内科 - 28.1 / 耳鼻 +36.5)

B 案 +297.3 万円

(内科 +222.1 / 耳鼻 +75.2)

現状の既読課金 (推計)

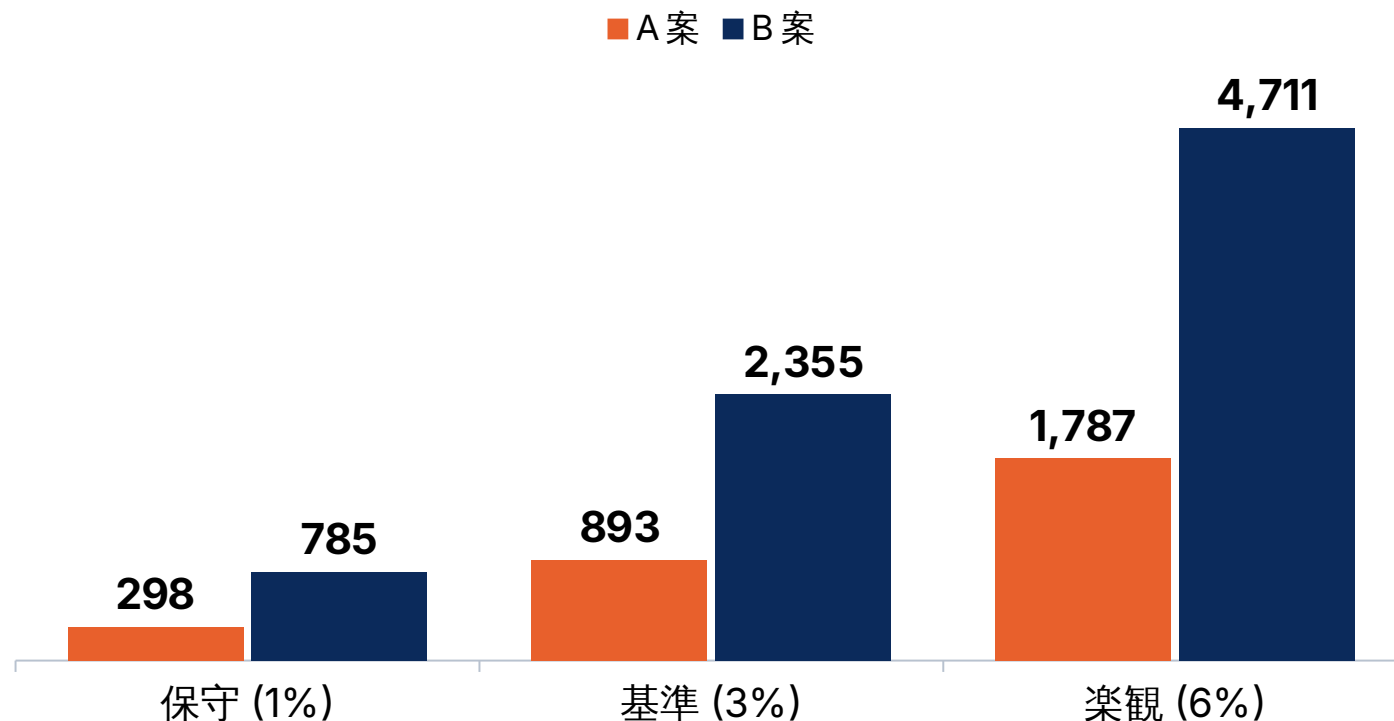
約 2,298 万円

→ 5,000 名で作った配信ルールを、科ごとの倍率で全国の内科・耳鼻に当てはめる

全国の追加売上（試算・基準）は A 案 +893 万円、 B 案 +2,355 万円。まず A 案で検証する

全国の売上

全国の追加売上（年、万円）— 転換率の仮定別



計算の流れ（基準）

① 追加処方患者 = 新たに読む医師 × 潜在 × 転換率
A 案 約 330 人 / B 案 約 870 人

② 1人あたり売上 = 50 億円 × 87% ÷ 全国処方患者 16.2 万人
約 2.7 万円（参考値・未検証）

③ 追加売上 = ① × ②
A 案 +893 万円 / B 案 +2,355 万円

費用の増加（既読課金のみ）
A 案 +8.4 万円 / B 案 +297.3 万円

提案：① A 案で既読・理解度・処方率を検証 → ② 効果を確認できれば B 案 → ③ 全国展開を判断